

Un adolescente autista en su clínica

Para médicos de familia, enfermeros y profesionales de la salud mental — cuidar a un adolescente autista (aproximadamente de 12 a 18 años).

la idea principal

El autismo, a través del **monotropismo**, significa que la atención de un adolescente se concentra en unos pocos «túneles» profundos e intensos. La pubertad y la adolescencia añaden demandas multi-canal —cambios en las reglas sociales, la identidad, las citas, los cambios corporales— sobre un sistema para el cual el cambio rápido es costoso. Esta es la **edad crítica para la ansiedad, la depresión y el burnout**, y muchos adolescentes autistas (especialmente las niñas y géneros marginalizados) son **identificados por primera vez solo en situación de crisis**. Trate al joven como el experto en su propia experiencia.

Lo que puede observar — y lo que realmente está sucediendo

Puede observar...	Lo que suele suceder
Agotado, retraído, «no tiene ganas»; rechaza ir a la escuela	Probable burnout autístico o sobrecarga — distinto de la depresión y de la pereza
Autolesiones, pensamientos suicidas o presentación en crisis	Riesgo real y elevado en este grupo; a menudo es la primera señal de una necesidad no satisfecha
Intereses intensos y absorbentes; se resiste a dejarlos	Los intereses son identidad, regulación y recuperación — no obsesiones que deban limitarse
«Está bien» en la cita, colapsa después	Camuflaje pesado; el coste se paga más tarde
Necesita contacto escrito, evita el contacto visual, pausas largas	Comunicación de canal único + tiempo de procesamiento, no es mala educación

Intente esto

- **Ofrezca la herramienta AASPIRE AHAT** antes de la visita y una opción de cita **escrita o en línea**; muchos adolescentes se comunican mucho mejor por escrito.
- **Pregunte directa y por separado** sobre el estado de ánimo, la ansiedad, el burnout, el sueño, la alimentación y los pensamientos suicidas — utilizando preguntas concretas y literales.
- **Valide sus intereses** como legítimos; pregunte qué aman y proteja el acceso a ello.
- **Dé tiempo de procesamiento**; ofrezca enviar un resumen escrito después de la cita.
- **Involúcrelos en las decisiones** y respete su autonomía; establezca una rutina predecible y de baja carga sensorial para las citas de seguimiento.

Evite esto

- Confundir el **burnout autístico con la depresión** — tratarlo como depresión (o decir «haz un esfuerzo») puede agravarlo y aumentar el riesgo de suicidio.
- Presionar al adolescente para que camufle, haga contacto visual o «sea más sociable» como un objetivo.

- Suponer que una respuesta lenta o inusual significa que no entienden o que carecen de capacidad.

Cuándo buscar más apoyo

Dépiste la suicidalidad directamente — los adolescentes autistas tienen un riesgo elevado. Distinga el **burnout autístico** (agotamiento + pérdida de habilidades + reducción de la tolerancia a los estímulos; requiere *reducción de demandas, aceptación y permiso para desmascarar*) de la depresión. Aborde las necesidades sensoriales y prácticas relacionadas con la pubertad (menstruación, higiene) de forma concreta. Planifique la **transición a los servicios para adultos temprano**, centrada en los intereses del joven. Oriente hacia grupos de pares autistas y mentores — una amistad de alta calidad es poderosamente protectora.

Si el adolescente es una niña o de género marginalizado

El camuflaje llega a su punto máximo aquí y provoca muchos diagnósticos perdidos y costes en la salud mental. La presentación puede parecer la de una joven «ansiosa, perfeccionista, sociable en la superficie». Pregunte específicamente sobre el **agotamiento por camuflaje** y los síntomas internalizados.

Acerca de esta guía

Asistida por IA, derivada de los borradores de investigación del proyecto — la brève sobre el **Monotropismo** y el **Guide pour les praticiens et les soins de santé** (Partie 3.3 & 4). Utiliza el lenguaje de identidad primero. **Informativo — no es un consejo médico ni una herramienta de diagnóstico.** Adáptelo al individuo.

Fuentes clave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020, burnout); Pearson & Rose (2021, masking); Bradley et al. (2021, camouflaging); AASPIRE AHAT; Autism Awareness Australia (teen mental health). Las citas completas están en los borradores fuente.